UE B1.3 S1 · 27 OCTOBRE 2026

FIÈVRE AU RETOUR DE VOYAGE ET PALUDISME

QCM — questions et corrigés argumentés

CONSIGNE

Pour chaque question, cochez les bonnes réponses parmi A à E. Il peut y avoir **une, deux ou trois bonnes réponses**. Toutes les corrections sont regroupées après les questions.

40 questions · 8 thèmes · 3 niveaux de difficulté

Les propositions portent sur les notions du cours. Les détails de prescription et les protocoles doivent toujours être appliqués selon les références de service.

Retour de voyage

Q01 **Au retour d'un pays tropical, quelles causes doivent rester envisagées ?** Facile

- ☐ **A.** Une infection respiratoire courante.
- ☐ **B.** Une infection urinaire.
- ☐ **C.** Uniquement une parasitose tropicale.
- ☐ **D.** Une maladie tropicale selon l'exposition.
- ☐ **E.** Aucune infection si le séjour a été court.

Q02 **Quelles informations sont indispensables dans l'anamnèse du voyage ?** Facile

- ☐ **A.** Pays et régions traversés.
- ☐ **B.** Dates de séjour et de début des signes.
- ☐ **C.** Uniquement le numéro de vol.
- ☐ **D.** Activités et expositions pendant le séjour.
- ☐ **E.** Le nom du fournisseur de billets.

Q03 **Le patient est fébrile après un voyage. Quelles propositions respectent la démarche présentée ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Chercher d'abord les signes de gravité.
- ☐ **B.** Repérer les points d'appel cliniques.
- ☐ **C.** Écarter automatiquement la grippe car il est allé en Afrique.
- ☐ **D.** Raisonner sur les expositions.
- ☐ **E.** Demander les examens sans tenir compte des signes.

Q04 **Quels événements du voyage peuvent orienter le diagnostic ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Baignade en eau douce.
- ☐ **B.** Piqûres de moustiques.
- ☐ **C.** Consommation d'eau non sécurisée.
- ☐ **D.** Couleur de la valise.
- ☐ **E.** Marque de l'appareil photo.

Q05 **À propos des fièvres restant sans diagnostic dans certaines séries, quelles affirmations sont prudentes ?** Difficile

- ☐ **A.** Il existe des fièvres dont l'étiologie n'est pas identifiée.
- ☐ **B.** Le chiffre de la série garantit que tout patient guérit seul.
- ☐ **C.** Un résultat négatif ne dispense pas de revoir la gravité.
- ☐ **D.** Il faut toujours réaliser un panel illimité.
- ☐ **E.** Le taux observé n'est pas une règle individuelle.

Chronologie et signes

Q06 **Concernant les dates de voyage, quelles affirmations sont exactes ?** Facile

- ☐ **A.** La date de retour aide à situer la dernière exposition possible.
- ☐ **B.** La date de début des symptômes est utile.
- ☐ **C.** L'incubation remplace l'examen clinique.
- ☐ **D.** Les périodes d'incubation peuvent se chevaucher.
- ☐ **E.** Tous les pathogènes ont 7 jours d'incubation.

Q07 **Quelles affections sont citées pour des incubations plutôt courtes ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Certaines arboviroses.
- ☐ **B.** Diarrhée du voyageur.
- ☐ **C.** Toutes les hépatites chroniques.
- ☐ **D.** Toute infection à tropisme hépatique.
- ☐ **E.** Toujours une infection à P. ovale dormante.

Q08 **Quels éléments suggèrent une fièvre avec foyer ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Brûlures urinaires et douleur lombaire.
- ☐ **B.** Crépitants respiratoires et toux.
- ☐ **C.** Lésion cutanée inflammatoire localisée.
- ☐ **D.** Absence de tout symptôme associé.
- ☐ **E.** Exposition au soleil sans symptôme.

Q09 **Un patient revenu d'une zone palustre n'a plus de fièvre au moment du triage. Quelles propositions sont justes ?** Difficile

- ☐ **A.** Le paludisme reste possible.
- ☐ **B.** Une sensation fébrile ou des frissons sont à recueillir.
- ☐ **C.** La température normale exclut une parasitose sanguine.
- ☐ **D.** La notion de prophylaxie n'est pas suffisante pour exclure le risque.
- ☐ **E.** Le diagnostic doit attendre l'apparition d'une fièvre tierce.

Q10 **Face à un ictère fébrile après un voyage, que faut-il considérer ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Le paludisme.
- ☐ **B.** Certaines hépatites.
- ☐ **C.** La leptospirose selon exposition.
- ☐ **D.** Une cause nécessairement unique et évidente.
- ☐ **E.** L'absence de tout besoin d'examen.

Infectiologie et BMR

Q11 **Que désigne une BMR ?** Facile

- ☐ **A.** Une bactérie multirésistante.
- ☐ **B.** Un portage possible sans infection clinique.
- ☐ **C.** Une infection virale du voyageur.
- ☐ **D.** Un parasite des hématies.
- ☐ **E.** Un marqueur de glycémie.

Q12 **Devant des soins ou une hospitalisation à l'étranger, quels réflexes conviennent ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Recueillir le contexte des soins.
- ☐ **B.** Informer l'équipe de soins.
- ☐ **C.** Appliquer les mesures prévues par le protocole d'hygiène.
- ☐ **D.** Isoler automatiquement toute personne ayant quitté la France.
- ☐ **E.** Considérer que le paludisme se transmet par contact cutané ordinaire.

Q13 **Pour les hémocultures prescrites, quelles propositions sont correctes ?** Facile

- ☐ **A.** Respecter l'asepsie de prélèvement.
- ☐ **B.** Respecter le volume de remplissage prévu.
- ☐ **C.** Négliger l'étiquetage.
- ☐ **D.** Identifier correctement les prélèvements.
- ☐ **E.** Mettre moins de sang systématiquement pour éviter le risque.

Q14 **Un paludisme confirmé impose-t-il à lui seul un isolement contact ?** Difficile

- ☐ **A.** Non, pas pour la transmission palustre habituelle.
- ☐ **B.** Oui, car les globules rouges se transmettent par poignée de main.
- ☐ **C.** Des précautions peuvent être motivées par un autre risque associé au voyage.
- ☐ **D.** Le protocole d'hygiène local reste pertinent.
- ☐ **E.** Tous les cas nécessitent un isolement aérien.

Q15 **Au retour de voyage, quelles informations préventives rechercher ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Vaccinations réalisées.
- ☐ **B.** Chimioprophylaxie antipaludique et observance.
- ☐ **C.** Protections contre les piqûres.
- ☐ **D.** Un certificat de vaccin comme garantie absolue de protection.
- ☐ **E.** La marque du bagage.

Agent et cycle

Q16 **Quel agent est responsable du paludisme ?** Facile

- ☐ **A.** Un parasite du genre Plasmodium.
- ☐ **B.** Un protozoaire.
- ☐ **C.** Une bactérie du genre Streptococcus.
- ☐ **D.** Un champignon microscopique.
- ☐ **E.** Un prion.

Q17 **Quel organisme transmet habituellement le paludisme ?** Facile

- ☐ **A.** La femelle anophèle infectée.
- ☐ **B.** Le moustique vecteur.
- ☐ **C.** Un contact social ordinaire sans vecteur.
- ☐ **D.** Le rhinovirus.
- ☐ **E.** La mouche domestique dans tous les cas.

Q18 **Quelles étapes de Plasmodium se déroulent chez l'être humain ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Passage initial par le foie.
- ☐ **B.** Invasion des globules rouges.
- ☐ **C.** Multiplication parasitaire sanguine.
- ☐ **D.** Reproduction sexuée principale dans le moustique.
- ☐ **E.** Transmission du parasite par parole.

Q19 **Au sujet des formes parasitaires, quelles affirmations sont exactes ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Le sporozoïte est inoculé par le moustique.
- ☐ **B.** Le mérozoïte envahit les globules rouges.
- ☐ **C.** Le gamétocyte participe à la transmission vers le moustique.
- ☐ **D.** Le gamétocyte est un globule blanc.
- ☐ **E.** Le schizonte n'intervient jamais dans le cycle.

Q20 **Concernant P. vivax et P. ovale, qu'est-il juste de retenir ?** Difficile

- ☐ **A.** Des formes hépatiques dormantes peuvent exister.
- ☐ **B.** Des rechutes tardives sont possibles.
- ☐ **C.** Chaque nouvel accès résulte forcément d'une nouvelle piqûre.
- ☐ **D.** Le mécanisme doit être distingué de la simple recrudescence sanguine.
- ☐ **E.** Ces espèces sont des bactéries.

Physiopathologie

Q21 **Qu'est-ce que la cytoadhérence dans le paludisme à P. falciparum ?** Facile

- ☐ **A.** L'adhésion de globules rouges parasités à des microvaisseaux.
- ☐ **B.** Un phénomène impliquant des protéines exprimées à la surface des hématies infectées.
- ☐ **C.** Le passage de bactéries dans les urines.
- ☐ **D.** Une technique de frottis sanguin.
- ☐ **E.** Une réaction allergique universelle au médicament.

Q22 **Quelles manifestations peuvent résulter de la séquestration parasitaire ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Altération de la microcirculation.
- ☐ **B.** Défaillance d'organe.
- ☐ **C.** Atteinte neurologique grave.
- ☐ **D.** Disparition garantie de la parasitémie.
- ☐ **E.** Impossibilité d'une défaillance respiratoire.

Q23 **Que décrit le terme rosetting ?** Difficile

- ☐ **A.** Une hématie parasitée associée à des hématies non parasitées.
- ☐ **B.** Un phénomène d'agrégation distinct de la seule multiplication.
- ☐ **C.** Une technique de vaccination.
- ☐ **D.** Un mécanisme contribuant à l'obstruction microvasculaire.
- ☐ **E.** La forme infectante injectée par le moustique.

Q24 **Pourquoi l'évaluation doit-elle être rapide ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** L'aggravation peut survenir sans tableau très spécifique initialement.
- ☐ **B.** La cytoadhérence peut contribuer à des atteintes d'organes.
- ☐ **C.** Un accès palustre grave est possible.
- ☐ **D.** On peut toujours prévoir précisément l'heure du coma.
- ☐ **E.** Une fièvre tierce doit impérativement précéder tout signe grave.

Q25 **Quelles affirmations sur le cycle sont compatibles avec le cours ?** Difficile

- ☐ **A.** Le cycle érythrocytaire de P. falciparum est présenté autour de 48 h.
- ☐ **B.** La rupture des hématies libère de nouveaux mérozoïtes.
- ☐ **C.** Tous les globules rouges parasités deviennent immédiatement séquestrés.
- ☐ **D.** La phase hépatique précède la multiplication sanguine.
- ☐ **E.** Le moustique est l'hôte du cycle asexué humain.

Diagnostic et gravité

Q26 **Quels signes ou résultats doivent alerter sur la gravité ?** Facile

- A. Trouble de conscience.
- B. Détresse respiratoire.
- C. Hypoglycémie significative.
- D. Simple absence de fièvre au triage prise isolément.
- E. Couleur du bagage.

Q27 **Que permet l'examen du frottis sanguin ?** Facile

- A. Voir des parasites dans des globules rouges.
- B. Contribuer à identifier une espèce parasitaire.
- C. Estimer une parasitémie selon lecture.
- D. Remplacer toujours toute autre technique.
- E. Mettre en évidence toutes les infections tropicales.

Q28 **À propos des TDR de paludisme, quelles propositions sont prudentes ?** Intermédiaire

- A. Ils peuvent détecter certains antigènes parasitaires.
- B. Ils rendent service pour un diagnostic rapide.
- C. Leur performance dépend du test et du contexte.
- D. Ils rendent toujours superflue la microscopie.
- E. Ils sont identiques à une hémoculture.

Q29 **Concernant PCR et LAMP, quelles affirmations sont justes ?** Intermédiaire

- A. Ce sont des méthodes moléculaires.
- B. Elles ne correspondent pas à la même technique.
- C. Elles peuvent être sensibles selon les systèmes de laboratoire.
- D. LAMP est une simple coloration du frottis.
- E. La biologie moléculaire rend inutile tout examen clinique.

Q30 **Un patient avec parasitémie confirmée présente des convulsions. Quelles affirmations sont compatibles ?** Difficile

- A. C'est un signe possible d'accès grave.
- B. L'orientation et la surveillance deviennent urgentes.
- C. Une prise en charge adaptée des défaillances est nécessaire.
- D. Le patient est nécessairement en accès simple.
- E. Le traitement doit attendre trois accès fébriles rythmiques.

Traitements

Q31 **Quelles propositions respectent la distinction accès simple / grave présentée ?** Facile

- ☐ **A.** Accès simple : des associations orales peuvent être utilisées.
- ☐ **B.** Accès grave : artésunate IV dans le cours.
- ☐ **C.** Accès grave : la voie orale seule est toujours adaptée.
- ☐ **D.** Le lieu de soins dépend de l'état clinique.
- ☐ **E.** La classification n'a pas de conséquence thérapeutique.

Q32 **Quels couples sont cités parmi les antipaludiques oraux ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Artéméther-luméfantrine.
- ☐ **B.** Arténimol-pipéraquine.
- ☐ **C.** Amoxicilline-clavulanate.
- ☐ **D.** Atovaquone-proguanil.
- ☐ **E.** Ibuprofène-paracétamol.

Q33 **Après artésunate IV pour accès grave, que faut-il retenir ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Le relais oral complet est prévu dès que possible selon protocole.
- ☐ **B.** La seule amélioration clinique ne signifie pas traitement terminé.
- ☐ **C.** La surveillance continue selon les prescriptions.
- ☐ **D.** Le traitement s'arrête obligatoirement après une dose.
- ☐ **E.** Le patient peut reprendre une activité sans suivi.

Q34 **Sur les conditions de prise des antipaludiques oraux, quelles propositions sont exactes ?** Difficile

- ☐ **A.** Elles varient d'une association à l'autre.
- ☐ **B.** Le médicament précis prescrit doit être vérifié.
- ☐ **C.** La prise avec repas est universelle pour toutes les molécules.
- ☐ **D.** Arténimol-pipéraquine est cité comme nécessitant une prise à jeun.
- ☐ **E.** La posologie peut être déduite du seul nom de la maladie.

Q35 **Quelle surveillance après artésunate IV est citée ?** Difficile

- ☐ **A.** Recrudescence clinique/parasitologique.
- ☐ **B.** Anémie hémolytique retardée.
- ☐ **C.** Contrôles dans les semaines suivantes selon protocole.
- ☐ **D.** Aucune surveillance après sortie.
- ☐ **E.** Arrêt de tout contrôle si la fièvre disparaît.

Prévention et rôle IDE

Q36 **Quelles mesures participent à la prévention du paludisme ?** Facile

- ☐ **A.** Protection contre les piqûres.
- ☐ **B.** Moustiquaire imprégnée selon contexte.
- ☐ **C.** Chimioprophylaxie prescrite selon le risque.
- ☐ **D.** Prise systématique d'antibiotiques pour tous les voyageurs.
- ☐ **E.** Isolement contact de toutes les personnes de retour.

Q37 **Comment raisonner sur une chimioprophylaxie ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Tenir compte de la destination précise.
- ☐ **B.** Tenir compte du terrain et des contre-indications.
- ☐ **C.** Vérifier la molécule et les dates des prises.
- ☐ **D.** Appliquer une durée post-retour identique à toutes les molécules.
- ☐ **E.** Conclure à un risque nul sous prophylaxie.

Q38 **Une personne ayant suivi une prophylaxie consulte pour malaise après un voyage en zone palustre. Que faire ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Signaler le séjour et la prévention prise.
- ☐ **B.** Conserver le paludisme parmi les hypothèses.
- ☐ **C.** Évaluer et signaler les signes de gravité.
- ☐ **D.** Écarter automatiquement le paludisme.
- ☐ **E.** Attendre le prochain voyage pour consulter.

Q39 **Dans la prise en charge IDE, quels objectifs sont pertinents ?** Intermédiaire

- ☐ **A.** Respecter la qualité du prélèvement sanguin.
- ☐ **B.** Surveiller conscience et état hémodynamique selon l'état.
- ☐ **C.** S'assurer de la compréhension du relais oral prescrit.
- ☐ **D.** Modifier seul le traitement antipaludique si les symptômes changent.
- ☐ **E.** Déclarer sans contrôle toute température normale comme guérison.

Q40 **Quelles erreurs de raisonnement faut-il éviter ?** Difficile

- ☐ **A.** Confondre portage de BMR et infection palustre.
- ☐ **B.** Traiter toutes les régions tropicales comme un risque identique.
- ☐ **C.** Faire dépendre le diagnostic uniquement de la présence de fièvre lors de la consultation.
- ☐ **D.** Signaler les dates et détails du voyage.
- ☐ **E.** Distinguer prévention anti-vectorielle et médicamenteuse.

CORRIGÉS ARGUMENTÉS

Les réponses sont données uniquement ici, dans l'ordre des questions. Pour chaque item, distinguer ce qui est exact des propositions à écarter.

Retour de voyage

Q01 — Au retour d'un pays tropical, quelles causes doivent rester envisagées ?

Bonnes réponses : A, B, D

Les causes cosmopolites restent possibles ; les causes tropicales sont évaluées selon l'exposition.

Propositions à écarter : C. Uniquement une parasitose tropicale. ; **E.** Aucune infection si le séjour a été court.

Q02 — Quelles informations sont indispensables dans l'anamnèse du voyage ?

Bonnes réponses : A, B, D

Les lieux, dates et comportements aident à établir les risques et les délais d'incubation.

Propositions à écarter : C. Uniquement le numéro de vol. ; **E.** Le nom du fournisseur de billets.

Q03 — Le patient est fébrile après un voyage. Quelles propositions respectent la démarche présentée ?

Bonnes réponses : A, B, D

La démarche est systématique et orientée : gravité, clinique et exposition.

Propositions à écarter : C. Écarter automatiquement la grippe car il est allé en Afrique. ; **E.** Demander les examens sans tenir compte des signes.

Q04 — Quels événements du voyage peuvent orienter le diagnostic ?

Bonnes réponses : A, B, C

Les voies de transmission dépendent des comportements et des expositions réelles.

Propositions à écarter : D. Couleur de la valise. ; **E.** Marque de l'appareil photo.

Q05 — À propos des fièvres restant sans diagnostic dans certaines séries, quelles affirmations sont prudentes ?

Bonnes réponses : A, C, E

Une proportion non élucidée est décrite dans des études ; elle ne doit jamais retarder le diagnostic urgent ni devenir une assurance clinique.

Propositions à écarter : B. Le chiffre de la série garantit que tout patient guérit seul. ; **D.** Il faut toujours réaliser un panel illimité.

Chronologie et signes

Q06 — Concernant les dates de voyage, quelles affirmations sont exactes ?

Bonnes réponses : A, B, D

La chronologie oriente mais ne suffit pas à exclure une étiologie.

Propositions à écarter : C. L'incubation remplace l'examen clinique. ; **E.** Tous les pathogènes ont 7 jours d'incubation.

Q07 — Quelles affections sont citées pour des incubations plutôt courtes ?

Bonnes réponses : A, B

Le cours cite notamment diarrhée du voyageur et arboviroses comme exemples de présentations précoces. Les autres propositions sont trop générales ou relèvent de délais différents.

Propositions à écarter : C. Toutes les hépatites chroniques. ; **D.** Toute infection à tropisme hépatique. ; **E.** Toujours une infection à P. ovale dormante.

Q08 — Quels éléments suggèrent une fièvre avec foyer ?

Bonnes réponses : A, B, C

Les signes localisés orientent les examens, tout en gardant à l'esprit les risques d'importation.

Propositions à écarter : D. Absence de tout symptôme associé. ; **E.** Exposition au soleil sans symptôme.

Q09 — Un patient revenu d'une zone palustre n'a plus de fièvre au moment du triage. Quelles propositions sont justes ?

Bonnes réponses : A, B, D

La fièvre est fluctuante et la maladie peut être peu spécifique.

Propositions à écarter : C. La température normale exclut une parasitose sanguine. ; **E.** Le diagnostic doit attendre l'apparition d'une fièvre tierce.

Q10 — Face à un ictère fébrile après un voyage, que faut-il considérer ?

Bonnes réponses : A, B, C

L'ictère est un signe d'appel partagé par plusieurs infections.

Propositions à écarter : D. Une cause nécessairement unique et évidente. ; **E.** L'absence de tout besoin d'examen.

Infectiologie et BMR

Q11 — Que désigne une BMR ?

Bonnes réponses : A, B

Le portage ou l'infection à BMR concerne les bactéries résistantes, pas le paludisme.

Propositions à écarter : C. Une infection virale du voyageur. ; **D.** Un parasite des hématies. ; **E.** Un marqueur de glycémie.

Q12 — Devant des soins ou une hospitalisation à l'étranger, quels réflexes conviennent ?

Bonnes réponses : A, B, C

Le risque BMR nécessite une évaluation et des précautions selon les procédures, sans généralisation au seul voyage.

Propositions à écarter : D. Isoler automatiquement toute personne ayant quitté la France. ; **E.** Considérer que le paludisme se transmet par contact cutané ordinaire.

Q13 — Pour les hémocultures prescrites, quelles propositions sont correctes ?

Bonnes réponses : A, B, D

L'enseignant insiste sur la qualité de prélèvement, notamment le remplissage.

Propositions à écarter : C. Négliger l'étiquetage. ; **E.** Mettre moins de sang systématiquement pour éviter le risque.

Q14 — Un paludisme confirmé impose-t-il à lui seul un isolement contact ?

Bonnes réponses : A, C, D

La transmission habituelle implique un moustique vecteur ; les autres risques se jugent séparément.

Propositions à écarter : B. Oui, car les globules rouges se transmettent par poignée de main. ; **E.** Tous les cas nécessitent un isolement aérien.

Q15 — Au retour de voyage, quelles informations préventives rechercher ?

Bonnes réponses : A, B, C

Les vaccinations et mesures de prévention nuancent le risque sans l'annuler.

Propositions à écarter : D. Un certificat de vaccin comme garantie absolue de protection. ; **E.** La marque du bagage.

Agent et cycle

Q16 — Quel agent est responsable du paludisme ?

Bonnes réponses : A, B

Plasmodium est un protozoaire parasite.

Propositions à écarter : C. Une bactérie du genre Streptococcus. ; **D.** Un champignon microscopique. ; **E.** Un prion.

Q17 — Quel organisme transmet habituellement le paludisme ?

Bonnes réponses : A, B

La forme infectante est inoculée par l'anophèle femelle infectée.

Propositions à écarter : C. Un contact social ordinaire sans vecteur. ; **D.** Le rhinovirus. ; **E.** La mouche domestique dans tous les cas.

Q18 — Quelles étapes de Plasmodium se déroulent chez l'être humain ?

Bonnes réponses : A, B, C

Les phases hépatiques et sanguines se déroulent chez l'humain ; la reproduction sexuée chez le moustique.

Propositions à écarter : D. Reproduction sexuée principale dans le moustique. ; **E.** Transmission du parasite par parole.

Q19 — Au sujet des formes parasitaires, quelles affirmations sont exactes ?

Bonnes réponses : A, B, C

Ces trois formes interviennent à différentes étapes du cycle décrit en séance.

Propositions à écarter : D. Le gamétocyte est un globule blanc. ; **E.** Le schizonte n'intervient jamais dans le cycle.

Q20 — Concernant P. vivax et P. ovale, qu'est-il juste de retenir ?

Bonnes réponses : A, B, D

Les hypnozoïtes hépatiques expliquent des rechutes tardives pour ces espèces.

Propositions à écarter : C. Chaque nouvel accès résulte forcément d'une nouvelle piqûre. ; **E.** Ces espèces sont des bactéries.

Physiopathologie

Q21 — Qu'est-ce que la cytoadhérence dans le paludisme à P. falciparum ?

Bonnes réponses : A, B

La cytoadhérence participe à la séquestration microvasculaire.

Propositions à écarter : C. Le passage de bactéries dans les urines. ; **D.** Une technique de frottis sanguin. ; **E.** Une réaction allergique universelle au médicament.

Q22 — Quelles manifestations peuvent résulter de la séquestration parasitaire ?

Bonnes réponses : A, B, C

Le processus contribue aux complications cérébrales et multiviscérales.

Propositions à écarter : D. Disparition garantie de la parasitémie. ; **E.** Impossibilité d'une défaillance respiratoire.

Q23 — Que décrit le terme rosetting ?

Bonnes réponses : A, B, D

Le rosetting est un phénomène d'adhésion cellulaire associé à la physiopathologie grave.

Propositions à écarter : C. Une technique de vaccination. ; **E.** La forme infectante injectée par le moustique.

Q24 — Pourquoi l'évaluation doit-elle être rapide ?

Bonnes réponses : A, B, C

L'intervenant insiste sur l'imprévisibilité individuelle de certaines décompensations.

Propositions à écarter : D. On peut toujours prévoir précisément l'heure du coma. ; **E.** Une fièvre tierce doit impérativement précéder tout signe grave.

Q25 — Quelles affirmations sur le cycle sont compatibles avec le cours ?

Bonnes réponses : A, B, D

Le cours distingue hépatique/sanguin et explique la maturation avant séquestration.

Propositions à écarter : C. Tous les globules rouges parasités deviennent immédiatement séquestrés. ; **E.** Le moustique est l'hôte du cycle asexué humain.

Diagnostic et gravité

Q26 — Quels signes ou résultats doivent alerter sur la gravité ?

Bonnes réponses : A, B, C

Les défaillances d'organes et anomalies métaboliques font partie des signes cités.

Propositions à écarter : D. Simple absence de fièvre au triage prise isolément. ; **E.** Couleur du bagage.

Q27 — Que permet l'examen du frottis sanguin ?

Bonnes réponses : A, B, C

Le frottis est un examen microscopique parasitologique du sang.

Propositions à écarter : D. Remplacer toujours toute autre technique. ; **E.** Mettre en évidence toutes les infections tropicales.

Q28 — À propos des TDR de paludisme, quelles propositions sont prudentes ?

Bonnes réponses : A, B, C

Les TDR complètent l'arsenal ; un protocole encadre le diagnostic.

Propositions à écarter : D. Ils rendent toujours superflue la microscopie. ; **E.** Ils sont identiques à une hémoculture.

Q29 — Concernant PCR et LAMP, quelles affirmations sont justes ?

Bonnes réponses : A, B, C

PCR et LAMP recherchent du matériel génétique par des méthodes différentes.

Propositions à écarter : D. LAMP est une simple coloration du frottis. ; **E.** La biologie moléculaire rend inutile tout examen clinique.

Q30 — Un patient avec parasitémie confirmée présente des convulsions. Quelles affirmations sont compatibles ?

Bonnes réponses : A, B, C

Les signes neurologiques imposent une réaction immédiate dans ce contexte.

Propositions à écarter : D. Le patient est nécessairement en accès simple. ; **E.** Le traitement doit attendre trois accès fébriles rythmiques.

Traitements

Q31 — Quelles propositions respectent la distinction accès simple / grave présentée ?

Bonnes réponses : A, B, D

La gravité oriente voie et niveau de surveillance.

Propositions à écarter : C. Accès grave : la voie orale seule est toujours adaptée. ; **E.** La classification n'a pas de conséquence thérapeutique.

Q32 — Quels couples sont cités parmi les antipaludiques oraux ?

Bonnes réponses : A, B, D

Trois associations antipaludiques sont évoquées ; le choix est médical.

Propositions à écarter : C. Amoxicilline-clavulanate. ; **E.** Ibuprofène-paracétamol.

Q33 — Après artésunate IV pour accès grave, que faut-il retenir ?

Bonnes réponses : A, B, C

Le relais oral est une priorité explicitement soulignée à plusieurs reprises.

Propositions à écarter : D. Le traitement s'arrête obligatoirement après une dose. ; **E.** Le patient peut reprendre une activité sans suivi.

Q34 — Sur les conditions de prise des antipaludiques oraux, quelles propositions sont exactes ?

Bonnes réponses : A, B, D

Le cours attire l'attention sur les consignes alimentaires spécifiques ; pas de généralisation.

Propositions à écarter : C. La prise avec repas est universelle pour toutes les molécules. ; **E.** La posologie peut être déduite du seul nom de la maladie.

Q35 — Quelle surveillance après artésunate IV est citée ?

Bonnes réponses : A, B, C

Le suivi est présenté jusqu'à environ J28, avec vigilance sur l'hémolyse tardive.

Propositions à écarter : D. Aucune surveillance après sortie. ; **E.** Arrêt de tout contrôle si la fièvre disparaît.

Prévention et rôle IDE

Q36 — Quelles mesures participent à la prévention du paludisme ?

Bonnes réponses : A, B, C

Le cours insiste sur prévention anti-vectorielle et médicamenteuse individualisée.

Propositions à écarter : D. Prise systématique d'antibiotiques pour tous les voyageurs. ; **E.** Isolement contact de toutes les personnes de retour.

Q37 — Comment raisonner sur une chimioprophylaxie ?

Bonnes réponses : A, B, C

L'indication et la durée dépendent des caractéristiques du séjour et du médicament.

Propositions à écarter : D. Appliquer une durée post-retour identique à toutes les molécules. ; **E.** Conclure à un risque nul sous prophylaxie.

Q38 — Une personne ayant suivi une prophylaxie consulte pour malaise après un voyage en zone palustre. Que faire ?

Bonnes réponses : A, B, C

La prévention réduit le risque mais n'exclut pas une infection.

Propositions à écarter : D. Écarter automatiquement le paludisme. ; **E.** Attendre le prochain voyage pour consulter.

Q39 — Dans la prise en charge IDE, quels objectifs sont pertinents ?

Bonnes réponses : A, B, C

Préparation, surveillance, transmissions et éducation sont centrales, sans substitution à la prescription.

Propositions à écarter : D. Modifier seul le traitement antipaludique si les symptômes changent. ; **E.** Déclarer sans contrôle toute température normale comme guérison.

Q40 — Quelles erreurs de raisonnement faut-il éviter ?

Bonnes réponses : A, B, C

Les trois premières propositions sont des pièges ; une exposition s'analyse individuellement.

Propositions à écarter : D. Signaler les dates et détails du voyage. ; **E.** Distinguer prévention anti-vectorielle et médicamenteuse.